回答カード（3列）のたたき台

列：①導く一文　②参照した二次・三次資料　③一次資料の番号（番号だけ。下の一覧で開く）。内容は、原文で確認できた事実だけ（確認の記録は別の台帳にある）。たたき台（2026-10-28 版）であり、検討用の資料です。内容は参考情報で、実務の判断は必ず一次資料で確認してください。

① 導く一文	② 参照した二次・三次資料	③ 一次資料の番号
結核治療でリファンピシンを服用する患者に、「日焼け注意」は必要か 新規探索（2026-10-26） 添付文書（リファンピシン、ピラジナミド）にも、MSFの結核ガイドライン2025年版にも、リファンピシンの光線過敏症の記載はない。日焼け注意を伝えるなら、**1次資料の裏付けがあるものではなく、予防原則にもとづく自作の判断**として区別して伝える。	クリニックの解説ページ（3次。「日光過敏症」と記載）／ 光線過敏症の症例報告（まれ。リファンピシンが原因とされない報告も含む）	S-001 RFP添文 S-002 PZA添文 S-003 MSF結核2025
鉄剤をお茶で飲んでもよいか（クエン酸第一鉄ナトリウムの場合） 新規探索（2026-10-26） 添付文書にはタンニン酸を含む食品の併用注意がある（in vitro の報告にもとづく）。一方、クエン酸第一鉄ナトリウムを緑茶で服用しても、**鉄吸収の指標（血清鉄など）で抑制は認められなかった**研究が2件ある（少数・短期。ヘモグロビン上昇を指標にした報告は別途確認中）。	（該当なし）	S-005 鉄剤添文 S-008 久保田1990 S-009 小切間2001
心不全の患者に、水分制限は必要か 新規探索（2026-10-26） 2025年改訂版ガイドラインは、代償期の心不全で**1日1〜1.5 Lを目標とした水分制限を「弱く」推奨**している。一律の強制ではなく個別に判断し、トルバプタン内服中は脱水・高ナトリウム血症に注意する。塩分は、推奨を示せるだけのエビデンスがない。	東邦大学スライド（2020。「重症例・低Na血症に限る」とする旧整理）	S-006 JCS心不全2025
レルベア200の処方が出たら、COPDではなく気管支喘息と判断してよいか 新規探索（2026-10-26） 添付文書の効能欄では、COPDの効能は100エリプタまでで、**200エリプタは気管支喘息のみ**。したがって適応の範囲では喘息と考えられるが、適応外使用の可能性は否定できないので、断定（「100%」）はしない。	COPD診療の総説（Therapeutic Research 2024）	S-004 レルベア等添文

一次資料カード（土台。見たい時だけ開く）

番号をクリックすると、ここの該当カードに飛びます。取得日・取得方法は、別のAIが再確認しなくて済むための記録です。

▼ S-001　RFP添文

リファンピシン 添付文書（リファジン第6版 2026-06ほか）／PMDA

取得日：2026-10-26／取得方法：PMDA検索→XMLを展開して全文検索／台帳：V-03

▼ S-002　PZA添文

ピラジナミド 添付文書（ピラマイド原末 第1版 2023-03）／PMDA
取得日：2026-10-26／取得方法：同上／台帳：V-04

▼ S-003　MSF結核2025

MSF Tuberculosis 2025年版（PDF）
取得日：2026-10-26／取得方法：PDF取得→全文検索（photosensitiv 等）／台帳：V-05

▼ S-004　レルベア等添文

レルベア第3版 2024-06／テリルジー第5版 2025-08 添付文書／PMDA
取得日：2026-10-26／取得方法：PMDA検索→効能・用法欄／台帳：V-06

▼ S-005　鉄剤添文

フェロミア第2版 2025-02／フェロ・グラデュメット第2版 2024-07 添付文書
取得日：2026-10-26／取得方法：PMDA検索→全文検索（茶、タンニン）／台帳：V-07

▼ S-006　JCS心不全2025

2025年改訂版 心不全診療ガイドライン（日本循環器学会／日本心不全学会）
取得日：2026-10-26／取得方法：PDF→テキスト抽出→全文検索／台帳：V-12

▼ S-008　久保田1990

久保田ら 日本老年医学会雑誌 27:555（1990）
取得日：2026-10-26／取得方法：J-STAGE検索の抄録／台帳：V-10

▼ S-009　小切間2001

小切間ら 日本栄養・食糧学会誌 54:81（2001）
取得日：2026-10-26／取得方法：J-STAGE検索の抄録／台帳：V-11